ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 7

BIOMECÁNICA CLÍNICA DE LAS ALTERACIONES DEL MMII

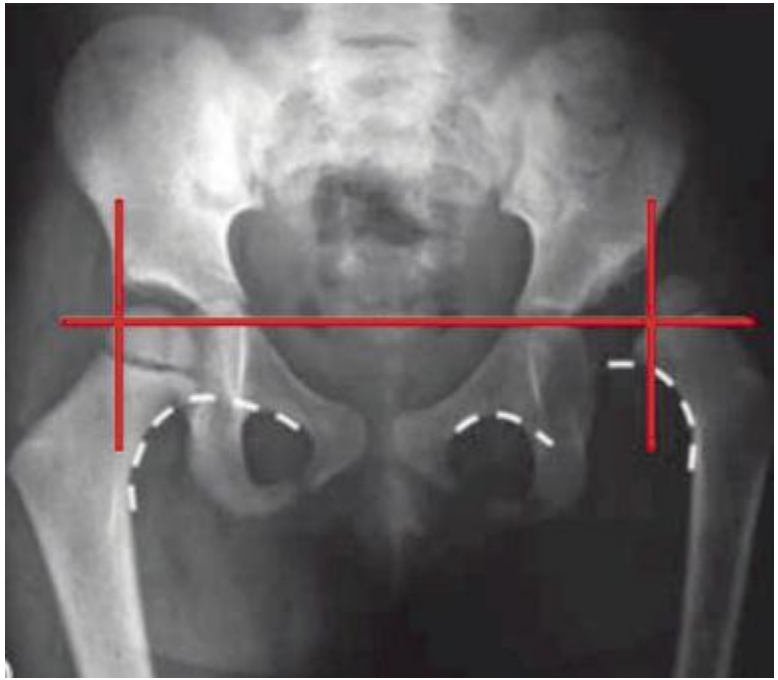
carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

DISPLASIA DE CADERA

- Es una anomalía del desarrollo cuya búsqueda es imprescindible en la valoración de los niños recién nacidos.
- Su diagnóstico precoz y manejo oportuno pueden evitar que los niños tengan lesiones que pueden perdurar toda su vida.
- Durante el crecimiento, al estirar las extremidades inferiores, la estabilidad articular depende de la cápsula articular y sus ligamentos; el acetábulo es más pequeño, comparado con el tamaño de la cabeza femoral, provoca mayor inestabilidad.



TIPOS DE LUXACIÓN

TERATOLÓGICA

Tiene su origen en una etapa temprana del desarrollo; los signos clínicos y radiológicos al nacer, son la manifestación de los cambios adaptativos de la pelvis y cabeza del fémur

TÍPICA

Es más frecuente, aparece y se desarrolla en el periodo perinatal, hay pocos cambios adaptativos, siendo las manifestaciones clínicas al nacimiento sutiles y los estudios radiográficos frecuentemente son normales.

Cadera luxada	La cabeza del fémur se encuentra completamente desplazada del acetábulo.
Cadera luxable	La cabeza se encuentra en el acetábulo pero puede ser desplazada completamente con una maniobra, para después volver a reducirse. Es la más frecuente
Cadera subluxable	La cabeza femoral se encuentra dentro del acetábulo pero se puede provocar su desplazamiento sin sacarlo de esta cavidad completamente

CAUSAS

Genético	• Hace suponer la mayor incidencia entre hermanos y familiares en primer grado. La hipótesis que se plantea para explicar el factor familiar es la de laxitud de los ligamentos en la familia.
Mecánicos	• Estos factores actúan por restricción del espacio intrauterino, en el último trimestre de la gestación. Se sugiere que los músculos abdominales y del útero de la madre dificultan los movimientos del feto, a lo que pueden contribuir situaciones como sobrepeso, macrosomía, gemelaridad.
Ambientales	• Situaciones tales como la forma en que se arropa en exceso a los niños o bien cuando esto se hace de tal manera que los niños permanecen en extensión, aumenta la incidencia de este padecimiento 10 veces.

EXPLORACIÓN ORTOPÉDICA

SIGNO DE GALEAZZI

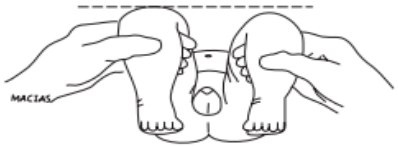


Figura 1. *Asimetría de extremidades. En decúbito supino con caderas y rodillas flexionadas, se observa asimetría de rodillas.*

MANIOBRA DE ORTOLANI

Figura 2. *Maniobra de Ortolani. Abducción del muslo y se estira presionando el trocánter hacia el borde acetabular.*

MANIOBRA DE BARLOW

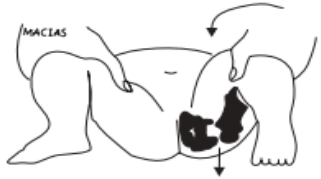
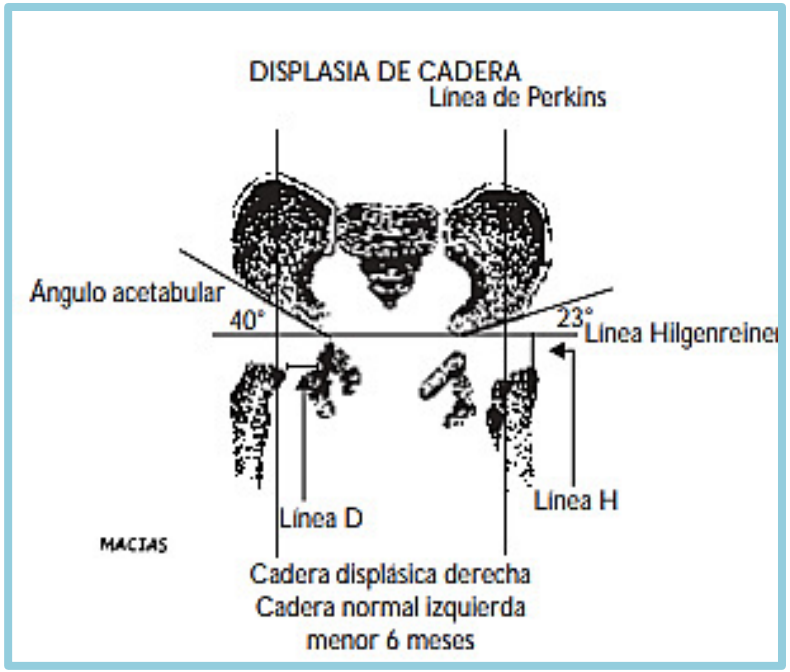
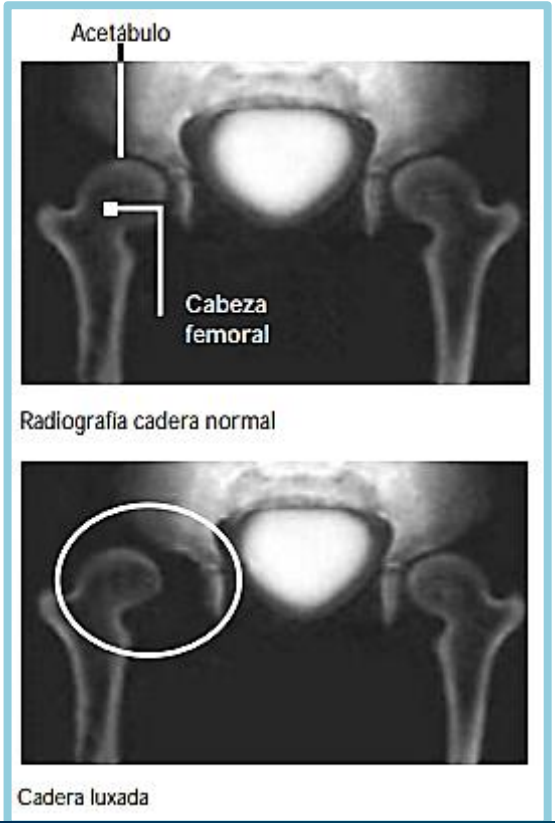


Figura 3. *Maniobra de Barlow. Las caderas con abducción a 45 grados se fija una cadera y se moviliza suavemente en aducción y abducción, y se desliza sobre el borde acetabular, empujando con el pulgar el cuello del fémur hacia afuera intentando luxarla.*

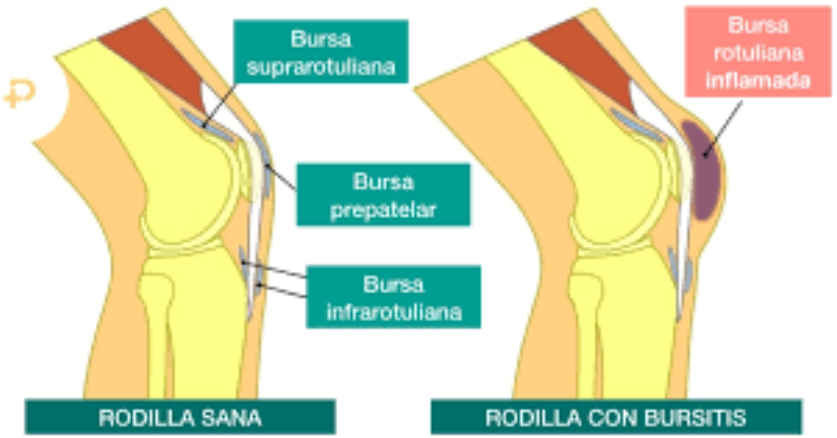

DISPLASIA DE CADERA
Línea de Perkins
Ángulo acetabular
40°
23°
Línea Hilgenreiner
Línea D
Línea H
MACIAS
Cadera displásica derecha
Cadera normal izquierda
menor 6 meses


Acetábulo
Cabeza
femoral
Radiografía cadera normal
Cadera luxada

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO

BURSITIS ROTULIANA

- Corresponde a una inflamación de la cara anterior de la rodilla.
- Las bursas sinoviales que suelen inflamarse por asociación con el trabajo, la frecuencia y la repetición de la presión de la patela son: la bursa prepatelar, la cual se encuentra ubicada directamente entre la superficie cutánea, la cara ventral de la patela y el ligamento patelar.



FISIOPATOLOGIA

- La inflamación se produce por el roce excesivo o la descarga de peso directa sobre la patela al encontrarse la persona arrodillada por largos periodos de tiempo.
- Esta inflamación generalmente es secundaria, con fricción constante entre la piel y la patela, y no solamente con presión en la zona.
- También puede ocurrir después de 8-10 días de haber recibido un golpe en el área, generalmente después de una caída. Se produce una inflamación con edema fluctuante y bien circunscrito en la zona de la rodilla, con aumento de temperatura en la parte más distal de la patela.
- En algunos casos, el líquido se puede infectar y complicar la evolución de la patología pasando a una bursitis séptica.

SÍNTOMAS

Dolor progresivo cuando hay contacto en la zona de la Bursa, sobre todo en una posición de flexión forzada de la rodilla
Pérdida de la funcionalidad con limitación al andar
Se produce tumefacción de los tejidos blandos
Aumento de temperatura
Rubor en la zona de la bursa

TRATAMIENTO KINÉSICO: ETAPA INICIAL

Estiramientos progresivos

Ejercicios isométricos para cuádriceps

Fortalecimiento leve con banda elástica de poca resistencia (si es que el cuadro clínico lo permite)

Ejercicio propioceptivo adaptado a la etapa y que permita realizar movimientos funcionales

TRATAMIENTO KINÉSICO: ETAPA AVANZADA

Estiramientos

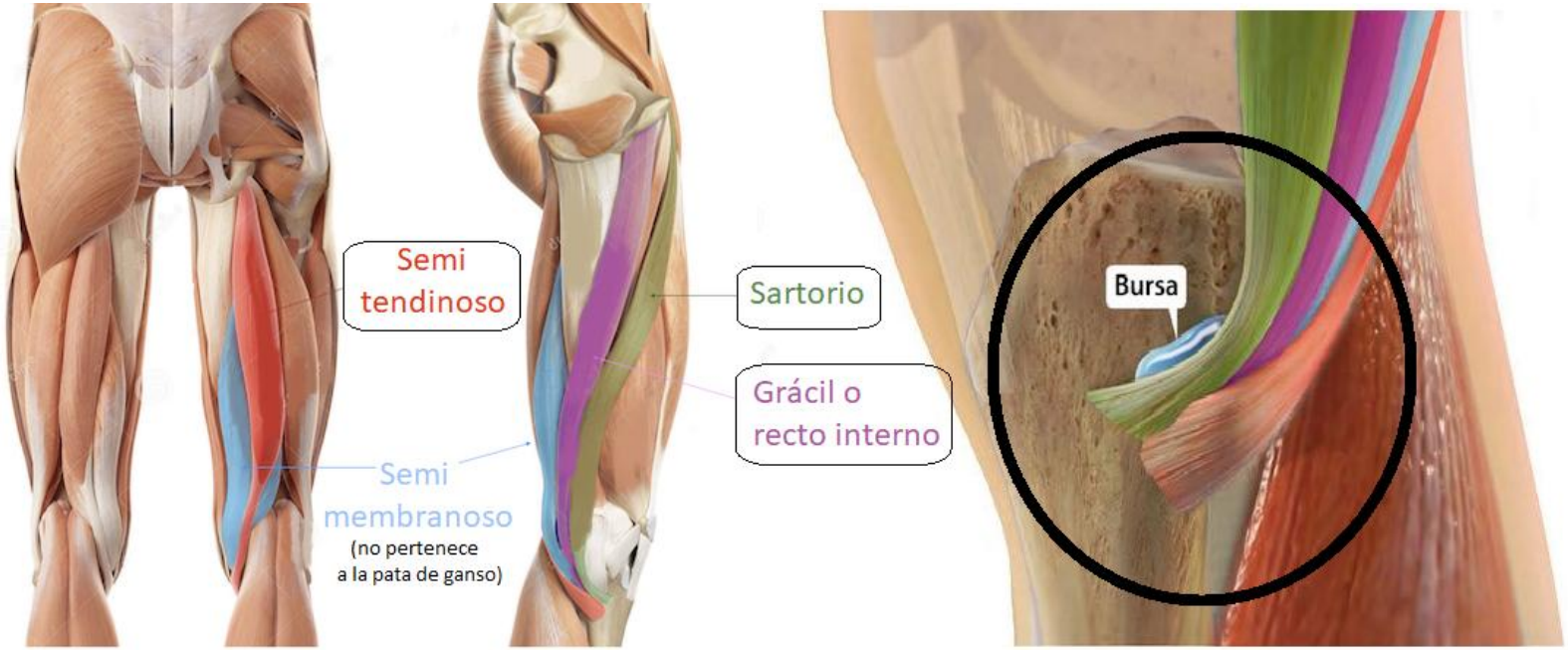
Fortalecimiento de cuádriceps con mayor carga y a tolerancia (se utilizan herramientas para aumentar la carga)

Ejercicio propioceptivo avanzado

PROPIOCEPCION

TENDINITIS ANSERINA

- Inflamación del tendón Anserino, también llamado **“Pata de ganso”.**
- Conformado por los tendones de los músculos: **semitendinoso, recto interno y sartorio.**
- Por su localización, compromete la integridad de la bursa anserina, produciendo también su inflamación.
- Frecuente en corredores y futbolistas.


Semi tendinoso
Sartorio
Grácil o recto interno
Bursa
Semi membranoso
(no pertenece a la pata de ganso)

CAUSAS

Pie plano, que ocasiona genu valgo y produce inflamación por repetición de movimiento
Prominencia ósea tibial
Traumatismo directo en la zona
Compromiso muscular de los músculos implicados

SÍNTOMAS

Dolor matutino y nocturno
Rigidez al iniciar movimiento
Sensación de ardor local
Movimientos como subir escaleras, levantarse de la silla, etc, son muy sintomáticos

TRATAMIENTO KINÉSICO: ETAPA INICIAL

Objetivo: disminuir la sintomatología del dolor y mejorar la movilidad

Liberación miofascial: S-RI-ST
Estiramientos progresivos
Evitar la pérdida del ROM por dolor, mediante ejercicios isométricos
Movilización articular

TRATAMIENTO KINÉSICO: ETAPA AVANZADA

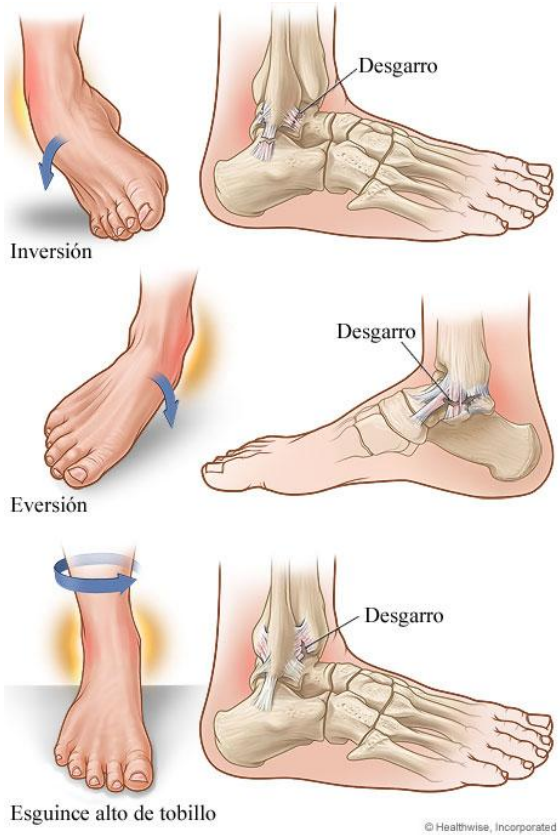
Objetivo: Mejorar la función tendinosa, flexibilidad muscular y fortalecimiento

Estiramientos dinámicos
Readaptación del tendón (fortalecimiento y ejercicio pliométrico)
Ejercicio de estabilidad (estatica y dinámica)

FISIO
DUAL
Ejercicios para
Tendinitis
Pata de Ganso

ESGUINCE DE TOBILLO

- Traumatismo de tracción ligamentosa que compromete la integridad de los ligamentos: peroneo astragalino anterior (PAA), peroneo astragalino posterior (PAP) y calcáneo peroneo (CP).
- Se produce principalmente por un mecanismo de inversión y el grado de afectación puede variar (grados: 1, 2 y 3), dependiendo de la estabilidad de la articulación, el terreno, calzado, factores propios de la persona, etc.


Desgarro
Inversión
Desgarro
Eversión
Desgarro
Esguince alto de tobillo
© Healthwise, Incorporated

SÍNTOMAS

Dependerá del grado de afectación, pero tomaremos en cuenta el grado 2 como ejemplo (más común para tratamiento).

Dolor en la zona de lesión (generalmente en lateral)
Pérdida de la funcionalidad al apoyo y esfuerzo
Hematoma
Aumento de temperatura
Inflamación

TRATAMIENTO KINÉSICO
Etapa inicial

Se tomará en cuenta el grado 2 como ejemplo.
Objetivo: Disminución de los síntomas

Movilidad articular
Ejercicio isométrico de músculos dorsiflexores y plantiflexores
Estiramiento Tríceps sural
Ejercicio propioceptivo inicial

TRATAMIENTO KINÉSICO

Etapa avanzada

Objetivo: Mejorar la función, fortalecimiento, estabilidad y flexibilidad.

Fortalecimiento específico de la musculatura comprometida + músculos afectados durante el proceso
Ejercicio propioceptivo avanzado (según contexto). Ejemplo: estabilidad estática y dinámica
Movilidad dinámica para mejorar la capacidad articular

Gracias por
su atención